

1. У породіллі виникла післяпологова депресія з психотичними ознаками. Вона постійно сумна, задумана, відмовляється від їжі, лежить у ліжку, відвернувшись до стіни. Яку загрозу для життя пацієнтки необхідно запідозрити в цьому разі?

- A. Авітаміноз
- B. Анорексію
- C. Розвиток пневмонії
- D. Суїцидальні думки та дії
- E. Виникнення пролежнів

2. У пацієнта віком 38 років спостерігається швидка зміна симптоматики у вигляді афективних коливань: від підвищеного до зниженого настрою. Симптоматика триває близько 2-х тижнів. Два і чотири роки тому у пацієнта спостерігалася депресивна симптоматика тривалістю 3 і 5 місяців. Який найімовірніший діагноз?

- A. Рекурентний депресивний розлад
- B. Біполярний афективний розлад, депресивний епізод
- C. Депресивний епізод помірного ступеня
- D. Маніакальний епізод
- E. Біполярний афективний розлад, змішаний епізод

3. Пацієнт віком 32 роки стверджує, що всі перехожі на вулиці спостерігають за ним, перешіптуються за спиною та передають інформацію про його місцезнаходження спецслужбам. Однак 'дружній' голос зсередини допомагає уникати підозрілих осіб. У минулому його неодноразово намагались отруїти шляхом нанесення хімікатів на одяг, через що перебуває оголеним. Для якого захворювання характерна така симптоматика?

- A. -
- B. Параноїдної шизофренії
- C. Шизотипового розладу
- D. Шизоїдного розладу особистості
- E. Маячного розладу

4. Укажіть лікарський препарат із доведеною ефективністю у лікуванні депресивної фази біполярного афективного розладу II типу.

- A. Луразидон
- B. Карбамазепін
- C. Літію карбонат
- D. Кветіапін
- E. Ламотриджин

5. Укажіть симптоми, які не пов'язані з нейрокогнітивними розладами.

- A. Гіпоманія
- B. Атрофія кори головного мозку
- C. Дратівливість
- D. Делірій
- E. Короткочасна втрата пам'яті

6. Пацієнт віком 68 років скаржиться на зниження пам'яті, складність запам'ятовування нової інформації, наприклад, не може згадати зміст статті, яку прочитав нещодавно, труднощі під час виконання повсякденних справ через забудькуватість, розгубленість. Під час опитування виявлено: труднощі з формулюванням фраз, добиранням потрібних слів. Об'єктивно спостерігається: періодично дратується, відсторонюється, замовкає. Зі слів дружини, стан погіршувався поступово протягом 2-х років, останнім часом іноді дезорієнтується на місці, не може зрозуміти, де він знаходиться. За результатами МРТ головного мозку виявлено: ознаки атрофії медіальної скроневої частки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Гентінгтона
- B. Хвороба Паркінсона
- C. Деменція з тільцями Леві
- D. Хвороба Альцгеймера
- E. Епілепсія

7. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на постійне відчуття тривоги, яке виникає майже одразу після пробудження та триває протягом дня. Тривога проявляється передчуттям, що ось-ось станеться щось дуже погане. Це супроводжується пришвидшеним серцебиттям, підвищеним артеріальним тиском, відчуттям 'кому' в горлі, нудотою, внутрішнім тремтінням та пітливістю. Перед сном тривога заважає заснути, пацієнтка відчуває м'язове напруження та не може розслабитися. Який найімовірніший діагноз?

- A. Генералізований тривожний розлад
- B. Агорафобія
- C. Неврастенія
- D. Obsесивно-компульсивний розлад
- E. Панічний розлад

8. Пацієнтку віком 70 років шпиталізовано до опікового відділення з опіками третього ступеня 35% тіла в результаті пожежі в будинку. Ввечері на 4-ий день перебування в лікарні вона дістає свою крапельницю та

починає кричати, що люди намагаються її поранити. Через кілька годин виявляється, що її важко розбудити та вона дезорієнтована. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Гострий стресовий розлад
- B. Поява основної деменції
- C. Короточасний реактивний психоз
- D. Гострий манакальний епізод
- E. Делірій

9. Пацієнт віком 35 років занепокоєний щодо втрати контролю над частотою та кількістю вживання ним алкоголю. Під час патофизиологічного дослідження виявлено: емоційна дизрегуляція, імпульсивність, знижена стресостійкість, схильність до тривалого пригніченого настрою. Унаслідок надмірної кількості термінових задач, перенапруженого робочого графіка та емоційного виснаження, пацієнт останнім часом складніше переживає кризові ситуації в усіх сферах життя. Відпустки зазвичай бере короточасні, але часті. Проводить їх, споживаючи значну кількість міцного алкоголю кілька днів поспіль протягом дня, не контролюючи ані поведінку, ані кількість випитого. Після припинення вживання відчуває симптоми загальної інтоксикації, слабкість, головний біль, відчуває деякий час відразу до алкоголю. Поза відпусткою алкоголь не вживає та жодного потягу до вживання не має. Аргументує таке вживання бажанням 'відновити свій настрій і зняти напруження'. Вирішив, що необхідна консультація лікаря, оскільки на похоронах близького родича не втримався і випив, 'щоб вгамувати горе', а далі були кілька днів постійного вживання без контролю випитого протягом дня. На момент огляду після 2-х днів припинення вживання потягу до алкоголю немає, повідомив про неприємні нюхові відчуття під час користування спиртовмісним антисептиком. Який патологічний стан спостерігається у пацієнта?

- A. Дипсоманія
- B. Делірій
- C. Абстиненція
- D. Дисфорія
- E. Неврастенія

10. Який синдром не характерний для шизофренії?

- A. Гебефренічний
- B. Судомний
- C. Галюцинаторно-параноїдний

- D. Кататонічний
- E. Апат-абулічний

11. Пацієнта віком 58 років шпиталізовано до травматологічного відділення з переломом стегна, який отримав під час весілля доньки. На третій день став агресивним, збудженим, тривожним. Наполягав на виписці, вважав, що він на м'ясокомбінаті і з нього хочуть зробити ковбасу. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 37,5°C, АТ - 160/90 мм рт. ст., ЧСС - 110/хв. Із анамнезу відомо, що періодично має псевдозапої. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Транзиторна ішемічна атака
- B. Стан відміни алкоголю з делірієм
- C. Стан відміни опіатів з делірієм
- D. Алкогольний галюциноз
- E. Стан відміни алкоголю без делірію

12. Під час огляду пацієнта віком 28 років спостерігається: ейфорія, неспокій, гіперактивність, легко відволікається, постійно та швидко говорить, не встигає завершити одну думку, як 'перестрибує' на іншу, роздає всім навколо поради. Також каже, що він найбагатший та найталановитіший чоловік у світі і має вплив на всі уряди світу. Рідні повідомили, що він останні дні взагалі не спав, витрачав купу грошей на непотріб, узяв велику суму в кредит. Яке лікування необхідно призначити пацієнту?

- A. Оланзапін + вальпроєва кислота
- B. Карбамазепін
- C. Сертралін
- D. Оланзапін + флуоксетин
- E. Ламотриджин

13. Пацієнт віком 14 років скаржиться на нічні страхи та ходіння уві сні протягом 2-х років. В анамнезі: у віці 2,4 і 7 років по одному фебрильному судомному стану під час інфекційного захворювання. Сомнамбулізм відзначався досить часто. Забіжуватий, жорстокий. З'явилися дисфорії. Який найімовірніший діагноз?

- A. Нічний енурез
- B. Бруксизм
- C. Епілептичні нічні пароксизми
- D. Дромоманія
- E. Фобії

14. Чоловікові, який намагався накласти на себе руки, стрибнувши з даху, завадили працівники поліції та медики. Був доставлений до психіатричного закладу,

проте від госпіталізації відмовляється. Яка стаття Закону України 'Про психіатричну допомогу' визначає підстави для примусової шпиталізації до психіатричного закладу, і чи слід її застосувати в цьому разі?

- A. Стаття 14, так
- B. Стаття 3, так
- C. Стаття 18, так
- D. Стаття 14, ні
- E. Стаття 18, ні

15. Під час огляду пацієнта віком 36 років виявлено: неспокійний, напружений, до чогось приглядається, прислухається, дату та місце перебування називає правильно. Настрій нестійкий, збудливий. Із анамнезу відомо, що два дні тому різко вийшов із запійного стану, який тривав 3 тижні. Об'єктивно спостерігається: тремор кінцівок, підвищена пітливість, АТ - 150/90 мм рт.ст., ЧСС - 110/хв. Який найімовірніший діагноз?

- A. 1-ша стадія алкогольного делірію
- B. 2-га стадія алкогольного делірію
- C. 3-тя стадія алкогольного делірію
- D. Реактивний психоз
- E. Патологічне сп'яніння

16. Пацієнт віком 35 років на скаржиться на те, що не може контролювати кількість вжитої їжі. На фоні хронічного стресу почав безконтрольно їсти ввечері. Припиняє прийом їжі тоді, коли шлунок наповниться до відчуття нудоти. Який патологічний стан спостерігається у пацієнта?

- A. Анорексія
- B. Булемія
- C. Розлад адаптації, пов'язаний зі стресом
- D. Орторексія
- E. Компульсивне переїдання

17. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на непереборне прагнення до викрадення різних предметів, навіть якщо вона не потребує їх і не має необхідності в них. Протягом декількох років відчуває нестерпну напругу перед тим, як щось вкрасти і спокій та полегшення після крадіжки. Розуміє, що це є неправильним та незаконним, але вона не може стримати себе від таких дій. Який розлад спостерігається у пацієнтки?

- A. Трихотиломанія
- B. Клептоманія
- C. Дромоманія

- D. Піроманія
- E. Дипсоманія

18. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на страх їхати самій за кермом в автомобілі, уникає поїздки у відрядження на автівіці, намагається організувати, щоб із нею їхав хтось із колег, якщо колеги не можуть, переносить зустріч на інший день. Стан виник після того, як рік тому, повертаючись ввечері з відрядження їй гостро стало погано, виникло прискорене серцебиття, не могла вдихнути, не могла нікому подзвонити з проханням допомогти. Схожі стани повторювалися двічі, сформувалась уникаюча поведінка, коли пацієнтка намагалась не залишатись сама у квартирі, не їхати сама в дорогу тощо. Який патологічний стан спостерігається у пацієнтки?

- A. Специфічна фобія
- B. Посттравматичний стресовий розлад
- C. Тривожно-депресивний розлад
- D. Панічний розлад
- E. Генералізований тривожний розлад

19. Пацієнта віком 22 роки шпиталізовано після того, як він був надзвичайно стурбований у своїй кімнаті гуртожитку, оскільки був упевнений, що адміністрація університету надсилає 'ударний загін', щоб убити його. Зазначає, що бачить 'видіння' чоловіків, одягнених у чорне, які мають зброю та переслідують його. Процес мислення пацієнта є відносно непорушеним, без блокування думки чи вільних асоціацій. Які препарати, найімовірніше, спричинили ці симптоми?

- A. Амфетаміни
- B. Барбітурати
- C. Героїн
- D. Бензодіазепіни
- E. MDMA (екстазі)

20. Пацієнт віком 28 років, спілкуючись із лікарем, безперервно щось говорить у дуже швидкому темпі. З великими труднощами, після кількох повторень вдається його перебити, щоб поставити питання. На запитання починає відповідати, але миттєво відволікається на іншу тему. Зміна теми у розмові пацієнта відбувається практично після кожної фрази. У разі якого розладу спостерігається таке прискорення асоціативного процесу?

- A. Шизофренії
- B. Психогенного психозу
- C. Біполярного афективного розладу

- D. Панічного розладу
- E. Епілепсії

21. Семирічний хлопчик під час занять у школі постійно розмовляє, відволікає інших учнів і не може дотримуватися інструкцій учителя. Також часто легко відволікається від своїх ігор та завдань удома, швидко переходячи від одного заняття до іншого без завершення попереднього. На огляді батьки повідомляють, що цей стан був майже завжди в дитини. Оберіть найбільш безпечний та ефективний препарат для лікування цього стану.

- A. Арипіпразол
- B. Гідазепам
- C. Гопантенова кислота
- D. Дексамфетамін
- E. Атомоксетин

22. Пацієнта віком 13 років батьки привезли до лікарні після того, як він підпалив їхній будинок. Його неодноразово шпиталізували у відділення невідкладної допомоги з різними симптомами, включаючи суїцидальність, гоміцидальність, неконтрольовані істерики. Які прояви найчастіше виявляють лікарі-психіатри у відділенні невідкладної допомоги у дітей віком до 12-ти років?

- A. Суїцидальність
- B. Хворобу Піка
- C. Неконтрольовані істерики
- D. Підпал
- E. Вбивство

23. Пацієнтка віком 32 роки звернулася вперше до лікаря-психіатра зі скаргою на 'провал у пам'яті', який, за її словами, стався з нею вперше в житті. Зазначає, що сьогодні раптово дізналася, що тиждень перебувала за кордоном, відвідуючи маму похилого віку, а повернулася 2 дні тому: з подивом для себе виявила відмітки в паспорті про в'їзд і виїзд, квитки, переписку з мамою і друзями щодо поїздки. Зовсім не пам'ятає ані обставин, ані часу, ані самого факту подорожі. Пацієнтка розповіла, що 2 тижні тому посварилася з чоловіком, він поведився агресивно, погрожував, шантажував. За словами знайомих, через кілька днів вона раптово вирішила поїхати до мами за кордон. Виглядала напруженою, тривожною, 'заклопотаною'. На момент огляду: орієнтована всебічно правильно, свідомість ясна, психопродуктивна симптоматика відсутня, емоційно лабільна, тривожна, місцями демонстративна

поведінка. Не може згадати жодної події чи факту з періоду після сварки і до повернення додому. Пам'ять на основні важливі події в минулому, імена, дати, обличчя, місця, а також на поточні події і короткострокова пам'ять без грубих порушень. Когнітивні функції в нормі. Неврологічний стан без патології. МРТ, КТ, ЕЕГ - без патологічних змін. Який найімовірніший діагноз?

- A. Антероретроградна амнезія
- B. Посттравматична амнезія
- C. Фіксаційна амнезія
- D. Ретардована амнезія
- E. Дисоціативна амнезія

24. Пацієнтка віком 36 років протягом останніх 10-ти років перебувала в державній психіатричній лікарні. Більшу частину дня проводить гоїдаючись, тихо бурмочучи собі під ніс або дивлячись на своє відображення в маленькому дзеркалі. Їй потрібна допомога з одяганням і прийняттям душу, вона часто хіхікає і сміється без видимої причини. Який найімовірніший діагноз?

- A. Біполярний розлад, маніакальна фаза
- B. Маячний розлад
- C. Шизофренія
- D. Шизоафективний розлад
- E. Шизофренний розлад

25. Пацієнтка віком 33 роки прибула до приймального пункту психіатричної лікарні у супроводі матері. Жінка неохайна на вигляд, із краплями крові на обличчі та верхньому одязі, у руках тримала шматок скла, яким намагалася нашкодити собі. За рішенням лікаря-психіатра пацієнтку шпиталізовано у примусовому порядку. Протягом першої доби перебування жінки у лікарні комісія лікарів-психіатрів та суд визнали доцільність примусової шпиталізації. Протягом якого часу пацієнтку повинна оглядати комісія лікарів-психіатрів для продовження стаціонарного лікування?

- A. 1 раз на добу
- B. 1 раз на місяць
- C. -
- D. 1 раз на тиждень
- E. 1 раз на півроку

26. Пацієнта віком 19 років привели до лікаря його батьки після того, як він подзвонив їм з університету, наляканий тим, що його переслідує мафія. Протягом останніх 6-ти тижнів не їв нічого, окрім

консервів, тому що їм усе подобається - я не можу бути надто обережним'. Перекоаний, що мафія встановила камери в його кімнаті гуртожитку і стежить за кожним його кроком. Час від часу він чує голоси двох чоловіків, які розмовляють про нього, коли нікого немає. Його співмешканка стверджує, що останні 2 місяці пацієнт став замкненим і підозрілим. Який найімовірніший діагноз?

- A. Шизофренія
- B. Маячний розлад
- C. Інтоксикація фенциклідом (PCP)
- D. Шизоафективний розлад
- E. Шизофренічний розлад

27. Жінку віком 72 роки виявлено у своєму помешканні у стані виснаження. Близьких родичів немає, з іншими родичами немає зв'язку. Кілька разів лікувалася у психіатричному стаціонарі. Мовний контакт малопродуктивний, на запитання відповідає часто не по суті, пам'ять різко погіршена, не пам'ятає, коли востаннє приймала їжу. Пересувається самостійно, проте з труднощами. За словами сусідів, уже днів десять не виходила з помешкання. Їжі вдома немає, навколо безлад і бруд. Від шпиталізації у психіатричний стаціонар категорично відмовляється, реагує агресивно. Яка лікувальна тактика в цьому разі?

- A. Поміщення у будинок-інтернат для хронічних пацієнтів
- B. -
- C. Виклик поліції та передача пацієнтки під опіку соціальних служб
- D. Шпиталізація до відділення інтенсивної терапії
- E. Примусова шпиталізація до психіатричного стаціонару

28. Яке з нижченаведених захворювань може розвиватися внаслідок довготривалого вживання алкоголю?

- A. ПТСР
- B. Цукровий діабет
- C. Грип
- D. Цироз печінки
- E. Астма

29. Військовослужбовець, у якого діагностовано посттравматичний стресовий розлад, звернувся зі скаргами на значне порушення сну, що проявляється стійкою інсомнією протягом останнього місяця. Який метод психотерапії

рекомендовано призначити в короткотерміновій перспективі згідно з рекомендаціями NICE?

- A. Дебрифінг
- B. Логотерапію
- C. Екзистенційну терапію
- D. Гіпнотерапію
- E. Арт-терапію

30. Пацієнтку віком 16 років шпиталізовано у тяжкому стані. Об'єктивно спостерігається: АТ - 75/50 мм рт. ст., ЧСС - 52/хв. В аналізі крові: K⁺ - 2,8 мекв/л, бікарбонати - 40 мекв/л. Батьки дівчини повідомляють, що вона схудла на 15 кг за 3 місяці, але все ще переконана, що має зайву вагу, їсть дуже невелику кількість низькокалорійної їжі та бігає 2-3 год щодня. Укажіть діяльність, що, найімовірніше, спричинила цей стан у пацієнтки.

- A. Крадіжки в магазині
- B. Статева розбещеність
- C. Самоіндукована блювота
- D. Зловживання алкоголем
- E. Носіння тісного одягу

31. Під час огляду пацієнтки віком 67 років спостерігається: охайно одягнута та зачесана, на привітання усміхається, у відповідь на різні питання не відповідає зовсім. Інструкції не виконує. Зі слів чоловіка відомо, що проблеми з пам'яттю почалися близько 7-ми років тому. Спочатку вона забувала, що робила нещодавно, потім перестала розрізняти родичів, вважала, що їй 35 років. Раніше часто залишала включеною плиту та воду. Одного разу вийшла самостійно з дому та загубилася. Потребує постійного догляду через втрату навиків самообслуговування. Який найімовірніший діагноз?

- A. Деменція при хворобі Гентінгтона
- B. Помірні (когнітивні) порушення пізнавальної функції органічного генезу
- C. Деменція при хворобі Піка
- D. Делірій, заподіяний деменцією
- E. Деменція при хворобі Альцгеймера

32. Щоранку, коли треба йти до школи, восьмирічна дівчинка стає плаксивою і засмученою, стверджує, що погано почувається, на уроках часто звертається до медсестри, зі скаргами на головний біль та біль у животі. Принаймні раз на тиждень пропускає заняття або мати забирає її раніше через скарги. Лікар-педіатр виключив органічні причини фізичних

симптомів. На вихідних у дитини зазвичай немає симптомів, якщо тільки батьки не вийдуть і не залишать її з нянею. Який найімовірніший діагноз?

- A. Розлад прихильності
- B. Генералізований тривожний розлад
- C. Велика депресія
- D. Розлад соматизації
- E. Розлад сепараційної тривоги

33. Пацієнтка віком 38 років не висловлює скарг, вважає себе здоровою. Об'єктивно спостерігається: вираз обличчя страдницький, очі сумні, говорить тихо, повільно, висловлює маревні ідеї самоприпинення та самозвинувачення. Із анамнезу відомо, що перестала спілкуватися з родичами, більшу частину часу лежить. Останні 2 тижні говорить про бажання вмерти, просить сина принести отруту або допомогти повіситися. Який стан є показанням для невідкладної шпиталізації пацієнтки?

- A. Загальмованість
- B. Депресивний зі стійкими суїцидальними висловлюваннями
- C. Відмова пацієнта від амбулаторного лікування
- D. Обсесивно-компульсивний
- E. Відсутність спілкування з родичами

34. Який основний елемент лікування отруєння метиловим спиртом?

- A. Введення етилового спирту
- B. Підтримання серцевої діяльності
- C. Форсований діурез
- D. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- E. Детоксикація

35. Пацієнта віком 19 років шпиталізовано в стані різкого психомоторного збудження. Об'єктивно спостерігається: голосно кричить, намагається втекти з палати, чує 'голоси', сам із собою говорить. Соматично та неврологічно стабільний. Діагностовано гострий психотичний розлад. Яку групу лікарських засобів необхідно призначити для невідкладної допомоги пацієнту?

- A. Антипсихотичні засоби
- B. Ноотропні засоби
- C. Антидепресанти
- D. Стабілізатори настрою
- E. Снодійні засоби

36. Пацієнт віком 62 роки до кабінету зайшов невпевненою човгаючою ходою.

Висловлює скарги на біль у м'язах, тремор у стані спокою, схильність до падінь, зниження пам'яті, труднощі під час запам'ятовування нової інформації, при згадуванні минулих подій, зниження концентрації уваги, порушення сну, плаксивість, зміни настрою. Під час обстеження говорить тихим монотонним голосом, періодично замислюється, замовкає, міміка збідніла, визначається ригідність м'язів за типом зубчастого колеса. Укажіть причину нейрокогнітивного розладу.

- A. Хвороба Гентінгтона
- B. Тільця Леві
- C. Хвороба Паркінсона
- D. Фронтально-темпоральне ушкодження
- E. Черепно-мозкова травма

37. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на напади пришвидшеного серцебиття, підвищення АТ, задишки, запаморочення, страху знепритомніти, страху залишатися наодинці, тремор тіла. Із анамнезу відомо, що такі стани спершу виникали раз на декілька днів, а тепер трапляються щодня, тривають до 30 хв і минають самостійно. Результати додаткових обстежень у нормі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Фобічний розлад
- B. Соматоформний розлад
- C. Посттравматичний стресовий розлад
- D. Емоційно-нестійкий розлад особистості, імпульсивний тип
- E. Панічний розлад

38. Для якого психічного розладу характерна розірваність мислення?

- A. Біполярного афективного розладу
- B. Шизофренії
- C. Епілепсії
- D. Неврозів
- E. Посттравматичного стресового розладу

39. Пацієнт віком 14 років, звернувся по допомогу у супроводі батька у зв'язку із нав'язливим страхом смерті батьків. Зі слів батьків, стан змінився протягом останнього року, коли хлопець почав молитися перед сном, щоб 'із батьками нічого не сталося'. З часом тривалість молитов збільшилася від кількох хвилин до 4 год, якщо збивався, то починав ритуал з початку, просив маму рахувати його молитви, щоб не збитися. Без цих ритуалів не випускав батьків з квартири, при цьому плакав або дратувався. Який імовірний розлад у дитини?

- A. Біполярний афективний розлад
- B. Гіперкінетичний розлад
- C. **Обсесивно-компульсивний розлад**
- D. Посттравматичний стресовий розлад
- E. Генералізований тривожний розлад

40. У пацієнтки віком 32 роки впродовж останніх 3-х тижнів виникли та наростали відчуття відкритості та 'чужості' думок, відчуття керування та впливу, ідеї відношення та впливу, голоси коментуючого характеру, зі зниженим настроєм, страхом та тривогою. Кілька років тому у пацієнтки спостерігався період підвищеного настрою, висловлювала надцінні ідеї власних можливостей, мала неадекватно багато планів, бралася за кілька справ одночасно, мало спала. По медичну допомогу не зверталася. Для якого розладу характерна така симптоматика?

- A. Гострого поліморфного психотичного розладу з симптомами шизофренії
- B. Депресивного епізоду
- C. Маніакального епізоду
- D. **Обсесивно-компульсивного розладу**
- E. **Шизоафективного розладу**

41. Пацієнт віком 38 років упродовж року брав участь у бойових діях. Після повернення додому вночі спить погано, зривається, кричить. Було кілька епізодів, коли при голосних звуках падав на землю та прикривав голову руками. За словами дружини, періодично змінюється на обличчі, стає неспокійним. Подразливий, легко афектує на рідних. Своїх переживань розкривати не хоче, від психотерапевтичної допомоги відмовляється, але погоджується приймати ліки. Який препарат доцільно призначити пацієнту?

- A. Сульпірид
- B. **Сертралін**
- C. Вальпроат натрію
- D. Кветіапін
- E. Прегабалін

42. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 16 років із дванадцятирічного віку змінився в поведінці, став 'дурником', часто неадекватним у поведінці та емоціях, бував деструктивним, спостерігалась розірваність мовлення та мислення. Для якого патологічного розладу характерна така симптоматика?

- A. Параноїдної шизофренії
- B. Кататонічної шизофренії

- C. Біполярного афективного розладу
- D. **Гебефренної шизофренії**
- E. Шизоафективного розладу

43. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 35 років протягом кількох годин поведив себе неадекватно, бігав по вулиці, чіплявся до перехожих, не реагував на зауваження, розмовляв сам із собою. Потім взяв лезо та порізав собі вени на обох передпліччях, пояснюючи, що не хоче жити. Пацієнту в травмункті оброблено рани, швів не накладено через неглибокі порізи. Яка подальша лікувальна тактика?

- A. Амбулаторна психотерапія
- B. Призначення амбулаторного лікування
- C. Призначення консультації психіатра
- D. **Шпиталізація до психіатричного відділення**
- E. Шпиталізація до хірургічного відділення

44. Пацієнтка віком 72 роки повідомляє, що її чоловік останнім часом зраджує їй. Незважаючи на те, що він інвалід із серцевою недостатністю і зовсім не виходить із дому, він нібито 'приймає у себе жінку', коли пацієнтка виходить до магазину. Знайшла у себе 'чужі жіночі речі'. Надалі з'ясувалося, що це її власні речі, які вона вже давно не носить. На спроби її переконати дратується й ображається. Який розлад спостерігається у пацієнтки?

- A. Параноїдна шизофренія
- B. Деменція при хворобі Альцгеймера
- C. Депресивний епізод із психотичними симптомами
- D. **Органічний маячний розлад**
- E. Органічний афективний розлад

45. У пацієнта віком 50 років, мисливця, після укусу лисиці з'явилися слабкість, головний біль, підвищена чутливість до звукових і світлових подразників, страх смерті, аерофобія, гідрофобія. Яка причина психічних порушень у пацієнта?

- A. Грип
- B. **Сказ**
- C. Енцефаліт
- D. Патологічний афект
- E. Інволюційний вік

46. Під час огляду десятирічної дитини виявлено: кричить, танцює, лається, заявляє, що все це робить не вона, а вчитель, який запанував її волею та керує. Вона знає, що говорить і робить 'непотрібне', але це все тому, що в її гортані

є щось стороннє: 'моя гортань підкорена чужій волі'. Визначте оптимальний препарат для лікування.

- A. Брекспипразол
- B. Зипразидон
- C. **Рисперидон**
- D. Каріпразин
- E. Оланзапін

47. Пацієнтці віком 28 років вперше діагностовано тяжку депресію. Призначено групову когнітивно-поведінкову терапію та лікування антидепресантом із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Через 4 тижні після початку лікування покращення психічного стану не спостерігається. Що першочергово має зробити лікар згідно з рекомендаціями NICE?

- A. Призначити інший антидепресант за бажанням пацієнтки
- B. **Переконалися, що пацієнтка приймає препарат регулярно та у відповідності до призначеної дози**
- C. Призначити інший антидепресант, якщо присутні побічні ефекти
- D. Збільшити дози відповідно до інструкції для медичного застосування препарату, за умови відсутності суттєвих побічних ефектів
- E. Розглянути можливість поєднання антидепресанту з іншим антидепресантом

48. У пацієнта інфекційного стаціонару розвинулося психомоторне збудження з порушенням орієнтації, розгубленістю, метушливістю, однотипними хаотичними рухами, мінливою мімікою, непослідовними фрагментарними висловлюваннями, які перериваються схлипуваннями, насильницьким сміхом. Який вид збудження виник у пацієнта?

- A. **Аментивне**
- B. Маніакальне
- C. Делірійне
- D. Гебефренічне
- E. Еретичне

49. Пацієнтку віком 16 років направлено на консультацію до лікаря-психіатра у зв'язку з аменореєю та низькою вагою (індекс маси тіла - 16). Мати дівчини стверджує, що протягом останнього року дівчина почала дотримуватися суворої дієти, обмежувала себе у вживанні води та постійно виснажувала фізичними заняттями.

Минулого тижня мати знайшла у дівчини діуретичні препарати. Дівчина заперечує наявність проблеми і заявляє, що в неї немає жодного дефіциту ваги. Який імовірний розлад у пацієнтки?

- A. **Нервова анорексія**
- B. Шизофренія
- C. Розлад відсутній, вікова норма
- D. Обсесивно-компульсивний розлад
- E. Посттравматичний стресовий розлад

50. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на депресію, тривогу, порушення сну, періодичну булімію, які тривають ще з раннього підліткового віку. За останні 5 років змінила кілька психотерапевтів, приймала різні медикаменти, однак суттєвого покращення не відчувала. Пацієнтка привертає увагу яскравим фарбованим волоссям, татуюваннями, неохайним одягом. Наносить собі пошкодження (припікає до шкіри цигарки, ріже лезом шкіру на передпліччях), періодично зловживає ПАР, часто зміни сексуальних партнерів та місце роботи, пояснюючи тим, що не може знайти спільну мову з колективом або ж організувати час так, щоб встигати виконувати свої обов'язки. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Межовий розлад особистості**
- B. Істеричний розлад особистості
- C. Залежний розлад особистості
- D. Ананкастний розлад особистості
- E. Антисоціальний розлад особистості

51. Чоловік віком 35 років чує 'голос' усередині голови, схожий на голос робота, який коментує усе, що відбувається навколо. За словами пацієнта, чує його вже 8-9 років. Спочатку здавалося, що це голос справжньої людини, проте згодом він змінився. Укажіть психопатологічний феномен у цього пацієнта.

- A. Афективна ілюзія
- B. Істинна галюцинація
- C. **Псевдогалюцинація**
- D. Парейдолія
- E. Функціональна галюцинація

52. Дванадцятирічного хлопчика привели до дитячого психіатра через конфлікт у школі та проблеми з навчанням. Він не зацікавлений у навчанні, не відвідує уроки, і його поведінка є асоціальною. Хлопчик агресивний, б'є і знущується з інших дітей, а також не показує жодних емоцій, коли його покарано. Його батько - колишній

в'язень, а мати не працює. Хлопчик був небажаною дитиною, що може бути причиною розчарування матері. У дитинстві він мав проблеми з адаптацією в дитячому садку і школі, а з часом ставав все більш проблемним учнем. Який патологічний стан спостерігається в пацієнта?

- A. Опозиційно-акцентуований розлад
- B. Асоціальний розлад поведінки
- C. Розлад соціальної поведінки
- D. -
- E. Розлад поведінки в межах внутрішньосімейних стосунків

53. Укажіть емоційний прояв, який не є типовим для циркулярної депресії.

- A. Туга
- B. Безнадійність
- C. Печаль
- D. Відчай
- E. Тривога

54. Який критерій забезпечує максимальну верифікацію діагнозу: шизофренія?

- A. Типові синдроми
- B. Генетичні дослідження
- C. Анамнез
- D. Катамнез
- E. Патопсихологічні дослідження

55. Пацієнтка віком 22 роки звернулася по амбулаторну психіатричну допомогу. Під час бесіди спостерігається швидке мовлення, піднятий настрій, на обличчі усмішка, підвищена рухова активність: активно жестикулює, змінює позу, іноді встає зі стільця. Під час розмови робить багато компліментів лікареві, коментує його висловлювання, дає поради. Повідомляє, що стан змінився 2 тижні тому, коли безпідставно став дуже гарним настроєм, підвищилася загальна активність, зменшилася потреба у сні та значно зріс статевий потяг. Визначте провідний психопатологічний синдром.

- A. Кататонічний
- B. Парафренний
- C. Параноїдний
- D. Гебефренічний
- E. Маніакальний

56. У пацієнта віком 32 роки у стані абстиненції послідовно виникли такі симптоми: погіршення настрою, дратівливість, озноб, тремор, мідріаз, нежить, біль у суглобах, блювання, пронос,

тонічні судоми. Для якого виду залежності характерна ця картина абстиненції?

- A. Опійної
- B. Канабіноїдної
- C. Ефедренової
- D. Барбітуратової
- E. Кокаїнової

57. Пацієнтка віком 33 роки скаржиться на біль у грудях. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка пильна та тривожна, ЧСС - 120/хв, АТ - 140/97 мм рт. ст., широко розширені зіниці. Токсикологічний аналіз позитивний. Який із нижченаведених препаратів, найімовірніше, спричинив таку симптоматику?

- A. Кокаїн
- B. Героїн
- C. Фенциклідин (PCP)
- D. Діетиламід лізергінової кислоти (ЛСД)
- E. Риталін

58. Пацієнтка віком 28 років, внутрішньо переміщена зі Сходу України, скаржиться на складність процесу засинання, наявність звуків 'ніби летить ракета', страх лягати спати, прискорене серцебиття, коливання артеріального тиску, відчуття постійної тривоги протягом дня, яка посилюється ближче до вечора. Із анамнезу відомо, що симптоми виникли 3 тижні тому, коли під час повітряної тривоги влучила ракета у будинок, а вона при цьому не пішла з дітьми в укриття, хоча постійно це попередньо робила. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Специфічна фобія
- B. Розлад адаптації пов'язаний зі стресом, у вигляді тривожно-фобічного синдрому
- C. Панічний розлад
- D. Інсомнія
- E. Посттравматичний стресовий розлад

59. Пацієнт віком 30 років із шизофренією скоїв тяжке кримінальне правопорушення під впливом хворобливих переживань. Направлений на судово-психіатричну експертизу. Яке питання має вирішити ця експертиза?

- A. Встановлення опікуництва
- B. Осудності чи неосудності
- C. Визначення групи інвалідності
- D. Дієздатності чи недієздатності
- E. Призначення нейрорептиків та їх дозування

60. Укажіть фактори, які можуть зумовити стійку втрату працездатності у пацієнтів з біполярним афективним розладом.

- A. Тривалість фазових станів протилежної спрямованості
- B. Тривалість фазових станів і 'світлих' проміжків
- C. Тривалість 'мішаних' фазових станів
- D. Тривалість і глибина фазових станів
- E. Тривалість і кількість фазових станів

61. Пацієнт віком 27 років скаржиться на головний біль, біль у суглобах, слабкість, катаральні явища, підвищення температури тіла до 39°C. Встановлено попередній діагноз: грип. На 3-й день захворювання на тлі високої температури тіла виникло глибоке затьмарення свідомості, порушення орієнтування в місцезнаходженні, часі, власній особистості, мислення і мовлення не пов'язані, пацієнт безладно борсається в ліжку, здригається, прагне підвестися. Викликано машину екстреної (швидкої) медичної допомоги. Яка тактика лікаря в цьому разі?

- A. Шпиталізація до терапевтичного відділення
- B. Шпиталізація до неврологічного відділення
- C. Шпиталізація до психіатричного стаціонару
- D. Шпиталізація до інфекційного стаціонару
- E. Шпиталізація до реанімаційного відділення

62. Пацієнта віком 56 років шпиталізовано з приводу інфаркту міокарда. Через два дні після шпиталізації він прокидається серед ночі і кричить, що біля вікна в його кімнаті стоїть чоловік. Коли медсестра входить до кімнати і вмикає світло, пацієнт із полегшенням дізнається, що 'людина' насправді була завісою біля вікна. Який із нижченаведених психіатричних термінів найкраще описує це неправильне сприйняття реальності?

- A. Ілюзія
- B. Галюцинації
- C. Омана
- D. Проекція
- E. Деменція

63. Пацієнтка віком 35 років повідомляє, що раніше двічі перебувала в депресивних станах тривалістю до 5-6 місяців. Наразі її

турбує відсутність притаманного їй задоволення від спілкування з близькими людьми (дітьми, чоловіком, батьками). Перестали радувати подарунки, компліменти, похвала. Зникла привабливість будь-яких матеріальних благ. У клінічній картині якої депресії спостерігаються такі симптоми?

- A. Депресії з обсессіями
- B. Анестетичної
- C. Депресії з маячними ідеями самозвинувачення
- D. Тривожної
- E. Ажитованої

64. У молодого чоловіка віком 21 рік через 1 рік після вживання наркотичної речовини розвинувся такий стан: перед очима з'явилися спалахи яскравого світла з неясними контурами трикутників, кіл. Незабаром після цього пацієнт побачив юрбу людей, які загрозливо дивилися в його бік. Спершу виникло почуття екстазу, що змінилося тривогою і занепокоєнням. Кольори і звуки стали насиченими, відчув, що душа відокремлюється від тіла. Цей стан тривав 10 год і завершився депресією. Визначте, яким наркотиком зумовлена описана картина інтоксикації.

- A. Барбітуратами
- B. Канабіноїдами
- C. Кокаїном
- D. ЛСД
- E. Героїном

65. Пацієнтку віком 20 років, яка раніше не мала серйозних проблем зі здоров'ям, шпиталізовано до відділення невідкладної допомоги її сім'єю через раптове погіршення стану. Вона проявляла високу активність, надмірну рухливість та пришвидшення мовлення. Цей гіперактивний стан із часом чергувався епізодами 'затримки', коли вона заплющувала очі і була нерухомою, кричала про невідомих нападників. У підсумку розвинувся стан ступору. Аналізи біологічних рідин та томографія не виявили відхилень. Визначте препарати першої лінії для невідкладної допомоги.

- A. Тіамін
- B. Діазепам
- C. Гідазепам
- D. Рисперидон
- E. Галоперидол

66. Укажіть принцип, за яким в Україні не надається психіатрична допомога під час планової шпиталізації.

- A. Недобровільності
- B. Необхідності й достатності заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації, надання освітніх, соціальних послуг
- C. Додержання прав людини та громадянина
- D. Гуманності
- E. Доступності до сучасного рівня наукових знань

67. Семирічному хлопчику діагностовано розлад дефіциту уваги з гіперактивністю та рекомендовано медикаментозну терапію. Який препарат можна призначити дитині?

- A. Метилфенідат
- B. Прегабалін
- C. Рисперидон
- D. Флуфеназин
- E. Гідроксизин

68. Пацієнта віком 23 роки шпиталізовано до психіатричного відділення з приводу параноїдної шизофренії з вираженим психомоторним збудженням. Призначено галоперидол 5 мг внутрішньом'язово. Протягом доби з'явилися судомні зведення м'язів кінцівок, язика, шиї. Яка подальша тактика лікаря для корекції ускладнень, що виникли?

- A. Додатково призначити тригексифенідил
- B. Додатково призначити стабілізатор настрою
- C. Підвищити дозу галоперидолу
- D. Додатково призначити ще один антипсихотичний засіб
- E. Додатково призначити антидепресант

69. До приймального відділення родичі привезли пацієнта віком 56 років, далекобійника за професією. Пацієнт повідомляє, що 'три дні тому перестав приймати таблетки і стало погано'. Об'єктивно спостерігається: дисфоричний, тривожний, метушливий, виражений дрібний тремор, підвищення АТ, тахікардія. Під час огляду стався генералізований тоніко-клонічний напад. Які психоактивні речовини, найімовірніше, вживав пацієнт?

- A. Транквілізатори
- B. Барбітурати
- C. Психостимулятори

- D. Трамадол
- E. Амфетаміни

70. Під час огляду десятирічної дитини виявлено: кричить, танцює, лається, заявляє, що все це робить не вона, а вчитель, який опанував її волю та керує. Вона знає, що говорить і робить 'непотрібне', але це тому, що в її гортані є щось стороннє, 'моя гортань підкорена чужій волі'. Який найімовірніший діагноз?

- A. Органічний маячний розлад
- B. Дитяча шизофренія
- C. -
- D. Реактивний параноїд
- E. Гострий поліморфний психотичний розлад

71. Пацієнтка віком 86 років останній рік спостерігається у психіатра з діагнозом: деменція при хворобі Альцгеймера з пізнім початком. За словами доньки, протягом останнього тижня стала агресивною, перестала спати вночі, звинувачує її в тому, що вона краде її речі, забирає у неї гроші та не дає їй їсти. Кликкала на допомогу сусідів, просила викликати поліцію, оскільки донька, на її думку, пускає отруйний газ у кімнату, хоче її заморити голодом та вбити, щоб заволодіти її квартирою. Який препарат буде засобом вибору для лікування цього стану?

- A. Аміназин
- B. Амісульприд
- C. Клозапін
- D. Левомепромазин
- E. Рисперидон

72. Пацієнта віком 52 роки направили до лікаря-психіатра після отримання дисциплінарного стягнення на роботі у зв'язку з постійним невчасним поданням звітів. Він наполягає на тому, що не збирається нічого здавати, поки це не буде 'ідеально, на відміну від усіх його колег' та відмовляється вірити, що проблеми мають щось спільне з його особистою поведінкою. У нього мало друзів через те, що він дратує їх своєю вимогливістю до 'точної своєчасності' і відсутністю душевного тепла. Який найімовірніший діагноз?

- A. Тривожний розлад, не уточнений іншим чином
- B. Емоційно нестабільний розлад особистості
- C. Біполярний розлад, змішаний стан
- D. Обсесивно-компульсивний розлад

Е. Обсесивно-компульсивний розлад особистості

73. Пацієнта віком 65 років, який у минулому часто зловживав алкоголем, шпиталізовано до психіатричної лікарні. Запевняє, що ніби знаходиться в 'іграшковому світі, де все нереальне та відчужене, а час стоїть на місці'. Як називається симптом, що виник у пацієнта?

- А. Дезорієнтація
- В. **Дереалізація**
- С. -
- Д. Деперсоналізація
- Е. Часткова амнезія

74. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на знижений настрій, страх, тривогу, безсоння, песимістичні думки, втрату зацікавленості, складність у зосередженні уваги, відчуття загальмованості. Симптоматика наростала впродовж останніх трьох тижнів, виникала 1-2 рази на рік упродовж останніх 5 років, переважно в осінньо-весняний період. Для якого патологічного стану характерна така симптоматика?

- А. Депресивного розладу із психотичними симптомами
- В. Маніакального епізоду
- С. Шизофренії
- Д. Депресивного епізоду помірного ступеня
- Е. **Рекурентного депресивного розладу**

75. П'ятирічного хлопчика привели до лікаря-психіатра через те, що він неуважний у школі, метушиться, не хоче сидіти в класі, удома надмірно балакучий і йому важко чекати своєї черги. Мовлення і моторика відповідають віку. Який найімовірніший діагноз?

- А. Опозиційний зухвалий розлад
- В. Легка розумова відсталість
- С. Тривожний розлад розлуки
- Д. Первазивне порушення розвитку
- Е. **Розлад дефіциту уваги з гіперактивністю**

76. У пацієнта діагностовано: обсесивно-компульсивний розлад. Призначено лікування циталопрамом. Через 4 тижні від початку лікування спостерігається позитивна динаміка, препарат є ефективним. Який мінімальний термін продовження лікування згідно з рекомендаціями NICE з метою запобігання рецидиву та для поліпшення результатів лікування?

- А. 4 місяці
- В. 3 місяці
- С. **12 місяців**
- Д. 2 місяці
- Е. 6 місяців

77. Пацієнт віком 56 років, інвалід II групи безстроково, через неефективність попередньої фармакотерапії переведений на лікування клозапіном. Визначте частоту проведення контролю абсолютної кількості нейтрофілів на початку лікування.

- А. **Щотижня**
- В. Щомісяця
- С. Щодвотижні
- Д. Щопівроку
- Е. Щокварталу

78. Пацієнт віком 27 років із шизофренією скаржиться, що періодично відчуває 'голоси' представників інопланетної цивілізації, що керують його думками та рухами за допомогою невідомих науці променів, примушуючи скоїти самогубство. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Деліріозний стан
- В. **Синдром психічного автоматизму**
- С. Ажитована депресія
- Д. Амбулаторний автоматизм
- Е. Маніакальне збудження

79. Пацієнт віком 39 років скаржиться на нав'язливі думки щодо розміру взуття (не може визначити, який підходить йому розмір - 43-й чи 44-й), що виникають спонтанно впродовж дня. Щодня заходить у взуттєві магазини, міряє взуття, вимірює свої стопи тощо. У дитинстві вголос зачитував номерні знаки машин, багаторазово перевіряв вміст ранця, по декілька разів вмикав-вимикав світло перед тим, як заснути. Який найімовірніший діагноз?

- А. Дисоціативний розлад
- В. Шизоїдний розлад особистості
- С. Синдром Аспергера
- Д. Генералізований тривожний розлад
- Е. **Обсесивно-компульсивний розлад**

80. Шестирічну дівчинку мама привела до лікаря зі скаргами на те, що дитина відстає в навчанні, неуважна, трапляються періодичні істерики на уроках та вдома. Зазначає, що дівчинка не розмовляла до 4-х років. У школі дружелюбна, але не може виконати більшість завдань, навіть якщо їй допомагають. Яка з нижченаведених

діагностичних процедур буде найбільш корисною для встановлення діагнозу?

- A. Люмбальна пункція
- B. Перевірка слуху
- C. Загальний аналіз крові
- D. Електроенцефалограма
- E. **Тестування IQ**

81. Пацієнтка віком 19 років з ІМТ - 19,5 кг/м² скаржиться на епізоди переїдання, які відбуваються зазвичай 3-4 рази на тиждень. Під час переїдання втрачає контроль і не може контролювати кількість спожитої їжі, після чого відчуває дискомфорт та відчуття переповненості в епігастрії. Після епізодів переїдання виникає сильне почуття провини та страху набрати вагу, оскільки вона вважає себе вже товстою. Через це після епізодів переїдання викликає блювання, іноді вживає проносні засоби та намагається робити якомога більше фізичних вправ. Який препарат є засобом вибору для медикаментозного лікування цього розладу?

- A. Амітриптилін
- B. Міртазапін
- C. Пароксетин
- D. Оланзапін
- E. **Флуоксетин**

82. Укажіть специфічний симптом, що характерний для отруєння метиловим спиртом.

- A. **Порушення зору**
- B. Сп'яніння від менших доз алкоголю
- C. Порушення дихання
- D. Блювання
- E. Тахікардія

83. Під час обстрілу в зоні бойових дій у військовослужбовця з'явилися такі симптоми: став тривожним, надмірно метушливим, гіперактивним, не виконував накази командира, неадекватно реагував на людей навколо. Упродовж двох годин стан покращився, симптоми стали менш вираженими, пам'ять на події, що відбувалися, частково втрачена. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Гостра реакція на стрес**
- B. Контузія
- C. Гострий поліморфний психотичний розлад
- D. Розлад адаптації
- E. Посттравматичний стресовий розлад

84. Під час огляду пацієнта віком 50 років виявлено: свідомість збережена, скарг не висловлює, ім'я лікаря не запам'ятав навіть після кількох повторень. Із анамнезу відомо, що зловживає алкоголем, тиждень тому мав порушення свідомості. Під час розпитування, де він був до епізоду порушення свідомості, сказав, що їхав на море, але раніше розповідав, що був на роботі. Настрій дещо підвищений, але подразливий. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Гентінгтона
- B. **Амнестичний синдром Корсакова**
- C. Хвороба Альцгеймера
- D. Енцефалопатія Гайє-Верніке
- E. Хвороба Піка

85. Пацієнтка віком 35 років звернулася до лікаря з проханням виписати рецепт на діазепам. Розповідає, що 2 місяці тому після сварки із сестрою виникло відчуття 'віднімання кінцівок', стала неспроможною самотійно стояти і ходити. Усі ці симптоми регресували після прийому діазепаму. З того часу приймала препарат по 1 таблетці 3 рази на день, упродовж 2-х тижнів - по 2 таблетки 3 рази на день. Тепер вважає таке дозування недостатнім. Висловлює скарги на тривогу, оніміння кінцівок, пітливість, відсутність апетиту, безсоння, які виникли після припинення вживання препарату. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вегетосудинна дистонія
- B. Маскована депресія
- C. Істеричний невроз
- D. **Залежність від транквілізаторів**
- E. Залежність від стимуляторів

86. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на появу неприємних відчуттів у внутрішніх органах, описує як 'відчуття жару в шлунку', 'стягування та перекручення кишечника'. В анамнезі: депресивний розлад. Оберіть симптом, який з'явився у пацієнтки.

- A. Парестезії
- B. -
- C. Вісцеральні галюцинації
- D. Синестезії
- E. **Сенестопатії**

87. Пацієнта віком 66 років шпиталізовано до психіатричної лікарні родичами у зв'язку із суїцидальними намірами. Під час бесіди неохоче повідомляє, що два місяці тому після психотравми з'явилася тривога,

внутрішній неспокій, порушився сон. Потім з'явилися голоси в голові, які нагадують йому про його гріхи, 'влаштовують Армагедон', вказують на його негідність, змушують виконувати їхні вимоги. Стверджує, що 'хтось вселився в нього та керує ним'. Який психопатологічний синдром спостерігається у пацієнта?

- A. Синдром Фреголі
- B. Паранояльний синдром
- C. Парафренний синдром
- D. Корсаковський синдром
- E. Синдром Кандинського-Клерамбо

88. Пацієнтка віком 38 років скаржиться, на те що протягом останнього року в неї виникло почуття суму, ніщо не приносить радість, з'явилися думки про смерть. Під час огляду лікарем довго сидить, не змінюючи скорботної пози, мовчазна, нічим не цікавиться, при звертанні відповідає тихо, монотонним голосом, після паузи. На обличчі застиг вираз страждання. Який психопатологічний синдром спостерігається у пацієнтки?

- A. Кататонічний
- B. Психоорганічний
- C. Депресивний
- D. Дементний
- E. Маніакальний

89. У пацієнта віком 59 років спостерігається прогресуюче погіршення пам'яті, безсоння. Почав помилятися при лічбі, забувати в розмові слова, перестав читати. Одного разу вийшов з дому і заблукав, не міг знайти дорогу додому. Об'єктивно виявлено: тривожний, неспокійний, не може сформулювати думку. Весь час перепитує одне й те саме. У просторі орієнтується погано, плутає дату, день тижня. Не впізнає себе у дзеркалі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Альцгеймера
- B. Корсаківський амнестичний синдром
- C. Тривожно-депресивний розлад
- D. Синдром Ганзера
- E. Дромоманія

90. Мати скаржиться, що їй важко доглядати за шестимісячним сином. Його дуже важко годувати або заспокоїти, він часто реагує на обійми плачем і застигає на руках у матері. За результатами фізичного обстеження та лабораторних досліджень відхилень не виявлено. Який із нижченаведених психічних розладів має

вищий ризик прояву в ранньому шкільному віці?

- A. Дитяча шизофренія
- B. Розлад поведінки
- C. Хвороба Піка
- D. Тривожний розлад розлуки
- E. Антисоціальний розлад особистості

91. Пацієнтка віком 32 роки із 22-річного віку хворіє на параноїдну шизофренію. Під час перебування на стаціонарному лікуванні з приводу загострення хвороби стан пацієнтки раптово погіршився: підвищилися температура тіла до 39,5°C, АТ - 160/100 мм рт. ст., обличчя гіперемоване, масне, губи сухі, вкриті кірочками, біло-коричневий наліт на язичку. Контакт майже недоступна, перебуває у ліжку. Яка лікувальна тактика у цьому разі?

- A. Люмбальна пункція
- B. Галоперидол
- C. Клопиксол-депо
- D. Жарознижувальні препарати
- E. Електросудомна терапія

92. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на неефективність призначеного лікування. Пацієнтку турбують постійна тривога, безсоння, дратівливість, нездатність концентруватися на роботі. На попередньому прийомі 5 днів тому лікар-психіатр встановив діагноз: генералізований тривожний розлад - та призначив есциталопрам у початковій дозі - 5 мг. Яка подальша тактика лікаря?

- A. Призначити препарат із похідних бензодіазепінів
- B. -
- C. Замінити на препарат групи ІЗЗСН
- D. Залишити препарат, пояснити механізм дії СИЗС
- E. Підвищити дозування препарату удвічі

93. Який розлад не належить до дисоціативних розладів?

- A. Одержимість
- B. Іпохондрія
- C. Розлад множинної особистості
- D. Амнезія
- E. Фуга

94. Яке з нижченаведених тверджень є характеристикою викликаних вживанням кокаїну розладів психіки та поведінки?

- A. Збільшення апетиту
- B. Покращення сну

- С. Підвищена розумова активність
- Д. Коагулопатія
- Е. **Параноя**

95. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на страшні картини в голові. Наприклад, яскраво бачить, що матір і батька вбиває злочинець, зайшовши через двері, які вона залишила відчиненими. Хвилюється, що через її необачність може померти близька людина. Надзвичайно переживає через порядок у речах. Патологічно зосереджена на тому, щоб речі лежали на своїх місцях, витрачає на це багато часу. Як називаються думки та образи, що виникають у пацієнтки?

- А. Псевдогалюцинації
- В. **Обсесії**
- С. Ілюзії
- Д. Галюцинації
- Е. Марення

96. Пацієнтка віком 19 років у супроводі матері звернулася до лікаря-психіатра з приводу потягу до виривання волосся на голові. Зі слів пацієнтки, бажання виривати волосся з'явилося кілька років тому на фоні тривалого психоемоційного навантаження. Після виривання волосся відчуває зменшення внутрішньої напруги. На волосистій частині голови - симетричні ділянки облісіння, шкіра у місцях облісіння незмінена. Встановлено діагноз: трихотиломанія. Яка терапія вибору для пацієнтки?

- А. Призначення N-ацетилцистеїну
- В. Призначення селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну
- С. Електросудомна терапія
- Д. Призначення оланзапіну
- Е. **Когнітивно-поведінкова терапія, спрямована на зміну звичок**

97. Пацієнт віком 14 років не засвоює шкільну програму, особливо з математики. Мовлення фразове - у 4 роки, у дитячому садку був проблемний у поведінці, ламав іграшки. Насилу читає по складах, не може розв'язати прості задачі, не розуміє сенс простих прислів'їв і приказок. Закінчив лише 2 класи школи, повільний. В анамнезі: родова травма. Який найімовірніший діагноз?

- А. Розлад спектра аутизму
- В. Шизофренія
- С. Депресивний розлад
- Д. **Розумова відсталість**

Е. Затримка розвитку

98. Через два місяці після ДТП пацієнт скаржиться на появу 'видінь' у вигляді яскравого образу пережитого в минулому, що повторює травматичний досвід. Це супроводжується почуттям страху та заціпеніння і виникає під час гучних сигналів автомобіля або при спалахах яскравого світла. Який симптом виник у пацієнта?

- А. **Флешбек**
- В. Дерезалізація
- С. Галюцинація
- Д. Криптомнезія
- Е. Деперсоналізація

99. Пацієнт віком 25 років звернувся до лікаря-психіатра у супроводі сестри. Пацієнт заходив неохоче, перед тим, як сісти на стілець, двічі провів рукою перед обличчям, пояснивши: 'Для того, щоб забрати негативну енергетику попереднього пацієнта'. Сестра вказує: 'Брат почав дивно себе поводити, одягатися лише у білий колір, носити з собою велику кількість різних амулетів, ні з ким не хоче спілкуватися, окрім сім'ї, уникає інших, оскільки не може їм довіряти через неістинність в енергетичному полі'. Пацієнт у розмові неактивний, на питання відповідає нечітко, переважає обставинне мислення. Який розлад особистості можна запідозрити у пацієнта?

- А. **Шизотиповий**
- В. Антисоціальний
- С. -
- Д. Межовий
- Е. Параноїдний

100. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на страх вийти з дому, переходити вулиці, відвідувати парк, через який пролягає її шлях на роботу. Змушена викликати машину, щоб дістатися роботи. Внаслідок генералізації страху взагалі перестала виходити на роботу, тому що виникає страх смерті, тремтіння в ногах, розгубленість, відчуття запаморочення, 'все розпливається перед очима'. Встановлено попередній діагноз: агорафобія. Укажіть препарати вибору для лікування цього розладу.

- А. Інгібітори моноамінооксидази
- В. Бензодіазепіни
- С. **Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну**
- Д. Селективні інгібітори зворотного захоплення норадреналіну

Е. beta-блокатори

101. Пацієнтку віком 26 років чоловік привіз до лікарні після того, як вона почала кричати, що їй дзвонять діти, і впала в істерику. Чоловік стверджує, що 2 тижні тому двоє їхніх дітей загинули в автомобільній аварії, і з того часу дружина була збуджена, неорганізована, заявляла, що не буде їсти, тому що вважає, що він отруїв їй їжу. Останні 2 дні не спала. Вважає, що медсестри у відділенні збираються завдати їй шкоди. Жінку заспокоюють і згодом відправляють додому. Через тиждень усі її симптоми стихають спонтанно. Який найімовірніший діагноз?

- А. **Короткий психотичний розлад**
- В. Делірій
- С. Посттравматичний стресовий розлад
- Д. Велика депресія з психотичними ознаками
- Е. Шизофренний розлад

102. Група з шести підлітків курять цигарки. Через 10 хв стають веселими, голосно сміються, незважаючи на подив перехожих, гримасують, стрибають. У трьох виникло відчуття, що гілки дерев під ногами перетворилися на величезні колоди. Це спричинило новий вибух реготу. Який наркотик вживали підлітки?

- А. **Марихуану**
- В. Амфетамін
- С. ЛСД
- Д. Екстазі
- Е. Крек

103. Пацієнта віком 52 роки шпиталізовано до травматологічного відділення з переломом стегна, який отримав під час весілля доньки. На третій день став агресивним, збудженим, тривожним. Наполягав на виписці, вважав, що він на м'ясокомбінаті і з нього хочуть зробити ковбасу. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 37,5°C, АТ - 160/90 мм рт. ст., ЧСС - 110/хв. Із анамнезу відомо, що періодично має псевдозапої. Який лікарський засіб необхідно призначити у цьому разі?

- А. Тіамін
- В. Рисперидон
- С. **Діазепам**
- Д. Галоперидол
- Е. Гідазепам

104. Дев'ятирічний хлопчик направлений до психіатра через низьку успішність та неслухняність у школі. Результати оцінки інтелекту не виявили порушень, IQ знаходиться в межах норми. Учитель повідомляє, що порівняно з іншими в класі, хлопцю важко утримувати увагу, він дуже непосидючий та метушливий, постійно нудиться та відволікає інших під час занять. Футбольний тренер хлопця та вчитель музики також вказують на його непосидючість та неухважність, які заважають навчанню та тренуванням. Який імовірний розлад у дитини?

- А. **Гіперкінетичний розлад**
- В. Генералізований тривожний розлад
- С. Специфічні порушення розвитку шкільних навичок
- Д. Розлад відсутній, вікова норма
- Е. Дитячий аутизм

105. Пацієнт віком 36 років щоденно багато разів на день миє руки, навіть якщо вони вочевидь чисті. Розуміє, що чергове миття є зайвим, прикладає зусилля, щоб не робити цього, але боїться забруднення та не може позбавитися нав'язливих дій. З якою метою здійснюють ритуали пацієнти з фобіями?

- А. **З метою запобігання якимось маловірогідним подіям, що зашкодять пацієнту, захисту від будь-якого нещастя**
- В. З метою протидії болісним переживанням
- С. Без будь-якої мети
- Д. З метою відвернення уваги від власних переживань
- Е. Пацієнт відчуває себе керованим, стверджує, що дії виконує мимовільно, під зовнішнім впливом

106. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на слинотечу, порушення ковтання, м'язові спазми, порушення сну та гарячку. Нещодавно була збільшена доза антипсихотичного препарату для лікування шизофренії. За результатами лабораторних досліджень виявлено: підвищення рівня креатинфосфокінази та лейкоцитоз. На момент обстеження пацієнтка знаходилася в стані збудження та зміненої свідомості. Який стан виник у пацієнтки?

- А. **Злоякісний нейролептичний синдром**
- В. Серотоніновий синдром
- С. Злоякісна гіпертермія

D. Центральний антихолінергічний синдром

E. Летальна кататонія

107. Пацієнт віком 22 роки протягом останніх 6-ти місяців став замкнутим, почав розмовляти сам із собою. Під час психіатричного огляду повідомляє, що чує 'голоси', які лунають у його голові та грудях. Сприймає 'голоси' як нереальні, штучні. Інтенсивність 'голосів' залишається однаковою протягом доби. Які розлади сприйняття можна припустити у пацієнта?

A. Дерезалізація

B. Ілюзії

C. Псевдогалюцинації

D. Справжні галюцинації

E. Метаморфопсії

108. Пацієнт віком 33 роки, стоячи у кутку палати, без будь-якої причини починає стереотипно присідати, хитати головою та тулубом, повторюючи за всіма, хто навколо, їхні слова та фрази. Прохань та інструкцій персоналу не виконує, під час спроби покласти його на ліжко став агресивним. Який стан спостерігається у пацієнта?

A. Гебефренічне збудження

B. Ажитована депресія

C. Істеричне збудження

D. Кататонічне збудження

E. Маніакальне збудження

109. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано до психіатричного стаціонару. Під час лікування став доступним для мовного контакту і повідомив лікарів, що протягом останніх двох тижнів перед шпиталізацією відчував зростання тривоги, погіршення сну та відчуття, що навколо нього відбувається щось дивне. У день шпиталізації він почув голос Бога всередині голови, який сказав: 'Ти маєш зустрітися з покійним батьком'. Перебуваючи вдома, він усвідомив, що його душа виходить із тіла та піднімається на небеса, а тіло залишається в кімнаті. На небесах він зустрів Бога, який провів його до покійного батька, із яким у нього була довга розмова. Під час цього він не реагував на зовнішні подразники, після чого дружина викликала швидку. Який синдром затьмареної свідомості спостерігається у пацієнта?

A. Деліріозний

B. Аментивний

C. Розгубленості

D. Сутінковий

E. Онейроїдний

110. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 35 років протягом життя був тривожним з приводу власного здоров'я, часто відвідував лікарів із постійними скаргами. Під час пандемії коронавірусної хвороби став ще більш тривожним, з'явився страх заразитися вірусом, постійно вимірював температуру тіла, шукав в Інтернеті інформацію про симптоми цього захворювання, незначні симптоми нежитю сприймав як загрозові для життя. Який найімовірніший діагноз?

A. Іпохондричний розлад

B. Панічний розлад

C. Депресія

D. Соціальна фобія

E. Астенічний невроз

111. Пацієнт віком 42 роки перебуває в стані оглушення, що періодично змінюється тривогою, відчаєм, афективними спалахами, гіперактивністю. На запитання не реагує. Відомо, що стан виник через декілька хвилин після бойових дій та триває 2 год. Який найімовірніший діагноз?

A. Гостра реакція на стрес

B. Конверсійна реакція

C. Тривожна реакція

D. Іпохондричний невроз

E. Параноїдна реакція

112. Визначте черговість (послідовність) хворобливих змін у різних психічних процесах у динаміці формування циркулярної депресії (від початку до 'розгорнутої' фази).

A. Емоційні, ефекторні (рухові), ментальні

B. Ментальні, емоційні, ефекторні (рухові)

C. Ефекторні (рухові), ментальні, емоційні

D. Емоційні, ментальні, ефекторні (рухові)

E. Ментальні, ефекторні (рухові), емоційні

113. Пацієнтка віком 24 роки починає психотерапію, стверджуючи, що вона водночас у відчаї та нудьзі, протягом останніх 5-ти або 6-ти років відчувала періодичну тривогу, депресію та зробила кілька суїцидальних жестів. Повідомляє про різні імпульсивні випадки та поведінку, що призводить до пошкоджень, а також сексуальну розбещеність. Задається питанням, чи може бути лесбійкою, хоча більшість її сексуального досвіду була з чоловіками. Раптово припинила дві

попередні спроби психотерапії, тому що злилася на лікаря, оскільки той не хотів призначати анкіолітики. Який найімовірніший діагноз?

- A. Емоційно нестабільний розлад особистості
- B. Дистимія
- C. Антисоціальний розлад особистості
- D. Гістрійонний розлад особистості
- E. Розлад контролю над імпульсами, не уточнений іншим чином

114. Який критерій не відповідає вимогам депресивного епізоду за МКХ-10?

- A. Ангедонія
- B. Підвищений настрій
- C. Пригнічений настрій
- D. Моторна загальмованість
- E. Ідеаторна загальмованість

115. У пацієнтки віком 75 років протягом останніх 10-ти років прогресивно погіршилася пам'ять. Останнім часом спричинила кілька невеликих кухонних пожеж, забувши вимкнути плиту, не може згадати, як готувати її улюблені страви, стає дезорієнтованою та розгубленою вночі. Вона ідентифікує все більше об'єктів як 'ту річ', оскільки не може пригадати правильну назву. М'язова сила та рівновага не порушені. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Кройтцфельда-Якоба
- B. Мультиінфарктна деменція
- C. Хвороба Вільсона
- D. Хвороба Гентінгтона
- E. Хвороба Альцгеймера

116. Пацієнт віком 24 роки малодоступний до мовного контакту, увага привертається складно. Не знає, який день, місяць, рік, вважає, що перебуває зовсім в іншому місці. Розлад якої сфери психічної діяльності розвинувся у пацієнта?

- A. Мислення
- B. Свідомості
- C. Немає ознак психічного розладу
- D. Настрій
- E. Сприйняття

117. Пацієнт віком 76 років прийшов на консультацію у супроводі доньки. За її словами, майже 5 років батько має великі проблеми з поведінкою: він став безініціативним, 'важким' на підйом, майже не доглядає за собою, відмовляється працювати у саду, хоча раніше це було його

улюбленим заняттям. Останнім часом з'явилися проблеми з пам'яттю: забуває поточні події, іноді не може пригадати, що їв зранку. У бесіді малопродуктивний, у відповідь частіше сміється, на пам'ять не скаржиться. Не зміг запам'ятати ім'я лікаря, назвати дату і місце зустрічі, координаторну пробу виконав із помилками. Який психічний розлад спостерігається у пацієнта?

- A. Органічний афективний розлад
- B. Деменція при хворобі Паркінсона
- C. Деменція при хворобі Альцгеймера
- D. Судинна деменція
- E. Деменція при хворобі Піка

118. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на часті епізоди переїдання, після яких вона викликає блювання або вживає проносні засоби, щоб уникнути збільшення ваги. Такі епізоди виникають принаймні двічі на тиждень упродовж останніх шести місяців. Зазвичай, це відбувається після стресових ситуацій або коли вона почувається тривожною. Епізоди переїдання викликають у неї значне відчуття провини, але вона не може контролювати їх. Який патологічний стан спостерігається у пацієнтки?

- A. Нервова анорексія
- B. Орторексія
- C. Компульсивне переїдання
- D. Психогенне переїдання
- E. Нервова булімія

119. Пацієнт віком 28 років скаржиться на порушення сну, зниження настрою, небажання спілкуватися з іншими людьми, потяг до споживання великої кількості їжі. Із анамнезу відомо, що завжди любив смачно поїсти, у дитинстві часто їв, коли йому було самотньо, сумно. Останнім часом усі думки лише про їжу. Вечори часто проводить на самоті, вживаючи багато їжі, після чого настрої погіршується, відчуває провини та відразу до себе. Який найімовірніший діагноз?

- A. Нервова анорексія
- B. Розлад компульсивного переїдання
- C. Депресивний розлад
- D. Нервова булімія
- E. Біполярний афективний розлад

120. Пацієнтку віком 24 роки шпиталізовано в стані збудження. Об'єктивно спостерігається: стогне, кричить, виє, риде, заламує руки, висловлює ідеї провини, втрати сенсу

життя, відчуває тривогу, тугу та відчай з відчуттям важкості за грудниною. Ризик виникнення якого невідкладного стану може бути у пацієнтки?

- A. Істеричного нападу
- B. Патологічного афекту
- C. Аменції
- D. Дисфорії
- E. Суїцидальної спроби

121. Який із нижченаведених лікарських засобів є блокатором опіатних рецепторів?

- A. Бупренорфін
- B. Апоморфін
- C. Морфін
- D. Налоксон
- E. Амфетамін

122. Пацієнт віком 30 років звернувся до лікаря-психіатра через те, що його звільнили за постійні запізнення на роботу. Стверджує, що відчуває небезпеку зараження мікробами, і тому змушений безперервно приймати душ, часто до восьми годин на день. Який нейромедіатор залучений до цього розладу?

- A. Серотонін
- B. Гістамін
- C. Ацетилхолін
- D. Дофамін
- E. Норадреналін

123. Дівчинка з легкою формою ДЦП у присутності матері, яка весь час робить їй зауваження, розгублюється, замовкає, не знає, як себе поводити. Які риси характеру можуть виникнути в дітей із дитячим церебральним паралічем у разі виховання в умовах надмірного навантаження та вимогливості?

- A. Рішучість
- B. Почуття власної гідності
- C. Переоцінка своїх можливостей
- D. Безпорадність
- E. Впевненість

124. У пацієнта віком 28 років упродовж останніх 2-х тижнів наростали такі симптоми: значне зниження реакції на зовнішні подразники та стимули, приймав та певний час утримував чудернацькі пози, часом 'застигав'. Для якого розладу характерні ці симптоми?

- A. Кататонічної шизофренії
- B. Депресивного ступору
- C. Шизотипового розладу

D. Параноїдної шизофренії

E. Гострого поліморфного психотичного розладу

125. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на поганий сон, часте тремтіння, запаморочення, нудоту, пітливість, напруження м'язів шиї та спини. Також відзначає неможливість зосередитися, розгубленість, постійне занепокоєння. За словами пацієнтки: 'вона впадає в паніку, що може статися щось погане'. Який найімовірніший діагноз?

- A. Агорафобія з панічним розладом
- B. Клімактеричний синдром
- C. Панічний розлад
- D. Змішаний тривожний і депресивний розлад
- E. Генералізований тривожний розлад

126. У пацієнта віком 34 роки діагностовано: тяжка депресія. Він і його лікар-психіатр обговорюють початок прийому антидепресантів. Пацієнта турбує ймовірність погіршення його здатності до ерекції під час прийому таких ліків. Який із нижченаведених препаратів необхідно почати приймати пацієнту, щоб вилікувати депресію, але уникнути цих симптомів?

- A. Флуоксетин
- B. Іміпрамін
- C. Кломіпрамін
- D. Дезипрамін
- E. Фенелзин

127. Під час огляду трирічної дитини виявлено: відсутність експресивного мовлення, нерозуміння зверненої мови, відсутність вказівного жесту. Зі слів батьків, у дитини спостерігається відсутність зацікавленості та гри з іншими дітьми, повторювані махання руками та виражена вибірковість у харчуванні. Який імовірний розлад у дитини?

- A. Гіперкінетичний розлад
- B. Нервова анорексія
- C. Посттравматичний стресовий розлад
- D. Розлад відсутній, вікова норма
- E. Дитячий аутизм

128. Які розлади сприйняття характерні для інтоксикації стимуляторів?

- A. Відчуття повзання комах по шкірі
- B. Слухові псевдогалюцинації
- C. Слухові галюцинації
- D. Порушення схеми тіла
- E. Зорові галюцинації

129. У пацієнтки віком 29 років раптово підвищилася температура тіла, погіршилося самопочуття, стала сонливою, проспала майже три доби. Із анамнезу відомо, що 4 дні тому хворіла на ГРВІ. Скаржиться на відчуття тривоги, запаморочення, двоїння в очах, 'викривлене бачення' навколишніх предметів, відчуття 'невагомості'. Об'єктивно спостерігається: птоз, ністагм, обличчя асиметричне, нестійка у позі Ромберга. Який найімовірніший діагноз?

- A. Генералізований тривожний розлад
- B. Епідемічний енцефаліт
- C. Сифіліс
- D. Розсіяний склероз
- E. Менінгококова інфекція

130. Пацієнт віком 45 років, директор, приймав пароксетин 40 мг/добу протягом 6-ти місяців від депресії. Оскільки його депресія була в повній ремісії протягом принаймні 3-х місяців, він вирішив припинити лікування, не поговоривши зі своїм лікарем-психіатром. Через 2 дні став дуже дратівливим, плаксивим, з'явилася нудота, тремор, запаморочення. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Синдром відміни СИЗС
- B. Реакція на зміну часових поясів
- C. Серотоніновий синдром
- D. Маніакальний епізод
- E. Рецидив його великої депресії

131. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на нестабільність настрою, відчуття порожнечі та невпевненості в собі. Розповідає, що з підліткового віку вона має нестійкі відносини з близькими та всіма навколо, періодично має депресію або відчуває епізоди гніву та агресії. Описує епізоди самоушкодження, зокрема різання себе з метою 'заглушити душевний біль фізичним болем'. Відзначає часту швидку зміну партнерів, оскільки швидко розчаровується в них, водночас відчуває страх залишитися самотньою. Який розлад особистості спостерігається в пацієнтки?

- A. Межовий
- B. Демонстративний
- C. Параноїдний
- D. Унікаючий
- E. Шизоїдний

132. Що є підставою для шпиталізації особи до психіатричного стаціонару у примусовому порядку?

- A. Наявність тяжкого психічного розладу, що зумовлює небезпеку пацієнта для себе або довкілля
- B. Наявність психічного розладу у особи, яка не становить небезпеки для себе або довкілля
- C. Необхідність обстеження в стаціонарних умовах
- D. Наявність хронічного психічного розладу
- E. Наявність тяжкого хронічного психічного розладу (слабоумство)

133. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на тривогу, очікування катастрофи, переживання про майбутнє, надмірне занепокоєння щодо справ на роботі, у сім'ї, фінансових питань. Протягом останніх шести місяців після зміни місця роботи турбує напруження м'язів, тремтіння, головний біль, пітливість, тяжкість у грудях, прискорене серцебиття, порушення сну, відчуття втоми, проблеми з концентрацією уваги. Який препарат першої лінії необхідно призначити згідно з рекомендаціями NICE?

- A. Кветіапін
- B. Сертралін
- C. Прегабалін
- D. Буспірон
- E. Амітриптілін

134. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 33 роки працював в іншій країні кухарем, проживав у досить складних умовах. Став помічати плутанину в думках, відчуття недоброзичливості та осуду з боку колег та оточення, зрозумів, що хтось впливає на його думки та хоче заподіяти йому шкоду. Насилу дістався додому, їхав кілька діб, тому що 'доводилося міняти транспорт через стеження'. Після повернення залишався підозрілим, не виходив із квартири кілька діб. Звернувся по допомогу на вимогу сестри. Відомо, що родич по материнській лінії покінчив життя самогубством у молодому віці. Який психічний розлад спостерігається у пацієнта?

- A. Параноїдна шизофренія
- B. Шизотиповий розлад
- C. Шизоафективний розлад
- D. Кататонічна шизофренія
- E. Органічний маячний розлад

135. Пацієнт віком 28 років скаржиться на безсоння, нудоту, блювання та страх. Об'єктивно спостерігається: пацієнт

дезорієнтований у місці та часі, орієнтований у власній особі, неспокійний, зривається з місця, ховається під ліжко та бачить навколо себе 'чорних жуків', яких топче ногами. Із анамнезу відомо, що зловживає алкоголем. Яке лікування є найбільш доцільним?

- A. Антидепресанти + препарати літію
- B. Анксіолітики + психотерапія
- C. Галоперидол + форсований діурез
- D. Діазепам + детоксикація
- E. Електроконвульсивна терапія

136. Пацієнтка віком 68 років послизнулася на кризі та вдарилася головою. Протягом наступних 3-х тижнів у неї з'являється постійний головний біль, вона стає все більш розсіяною та забудькуватою, а вночі наляканою та дезорієнтованою. Яка найімовірніша причина цієї симптоматики?

- A. Менінгіома лобової частки
- B. Хвороба Корсакова
- C. Епідуральна гематома
- D. Мультиінфарктна деменція
- E. Субдуральна гематома

137. Пацієнт віком 40 років скаржиться на порушення сну з кошмарними сновидіннями, поганий настрій, агресивність до оточення, гнітючі спогади: 'побиття палицями, обливання крижаною водою, які виникають раптово і відчуються реальними'. За словами пацієнта, спілкування з близькими погіршилося, адже вони 'не розуміють' його. Із анамнезу відомо, що чоловік брав участь у бойових діях та перебував у полоні, з якого повернувся 3 місяці тому. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гостра реакція на стрес
- B. Реакція на тяжкий стрес
- C. Посттравматичний стресовий розлад
- D. Порушення адаптації
- E. -

138. Пацієнтка віком 17 років під час огляду пасивна, інтересу до бесіди не виявляє, на запитання відповідає односкладово. Об'єктивно спостерігається: міміка збідніла, мислення паралогічне. Маячних ідей не висловлює, галюцинацій не виявлено. Із анамнезу відомо, що у 16-річному віці почала поступово змінюватися, втратила всі захоплення, перестала спілкуватися з подругами. В останні 2-3 місяці стала зовсім замкненою, з батьками майже не розмовляє, школу не відвідує, не мисться, не стежить за одягом,

їсть неохоче. Який клінічний діагноз можна встановити відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду?

- A. Параноїдна шизофренія
- B. Проста шизофренія
- C. Маніакальний епізод
- D. Депресивний епізод
- E. Шизотиповий розлад

139. Мати звернулася до дитячого психіатра через стереотипну поведінку та регрес мовлення свого шестирічного сина. З двох років мати помітила вибірковість у спілкуванні, порушення сну та вибірковість у їжі. У дитячому дошкільному закладі помічали відсутність вербального спілкування з іншими дітьми та вихователями, але збереження невербальних засобів комунікації. Психічний стан: зоровий контакт встановлюється на короткий час, емоційні реакції слабо диференційовані. Під час огляду виявляє стереотипну аутоагресію: щіпає, кусає себе, намагається битися головою. Оберіть препарат для лікування аутоагресії.

- A. Оланзапін
- B. Брекспразол
- C. Каріпразин
- D. Рисперидон
- E. Зипразидон

140. Пацієнт віком 30 років скаржиться на помітне зниження настрою, безсоння, а також відсутність бажання жити і думки про самогубство. Об'єктивно спостерігається: довгий час зберігає одну позу, відповідає неспішно та монотонним голосом, не може впоратися з роботою. В анамнезі: епізоди тривалістю більше тижня, багато працював, майже не спав і не їв. Оберіть препарат першої лінії лікування.

- A. Вальпроєва кислота
- B. Флуоксетин
- C. Сертралін
- D. Оланзапін
- E. Гідазепам

141. Пацієнт віком 58 років скаржиться на головний біль, дратівливість, безсоння, зниження пам'яті та настрою. Під час неврологічного обстеження виявлено: слабопозитивні менінгеальні симптоми, анізокорія з млявою реакцією зіниць на світло. Ввечері раптово розвинувся стан потьмареної свідомості із зоровими галюцинаціями, страхом, психомоторним

збудженням. За результатами дослідження ліквору виявлено: велику кількість білка та клітинних елементів, позитивну реакцію Васермана. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дисоціативно-конверсійний розлад
- B. Делірій. Сифіліс мозку
- C. Алкогольний делірій
- D. Тривожно-депресивний розлад
- E. Реактивний параноїд

142. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано зі скаргами на безсоння, бачить 'як по стінах лазять павуки'. Із анамнезу відомо, що зловживає алкоголем з 19-ти років, але не пив останні 3 дні. Об'єктивно спостерігається: тремтить, йому важко розповідати про те, що трапилося, АТ - 170/95 мм рт. ст., ЧСС - 100/хв, пітливість. Який найімовірніший діагноз?

- A. Алкогольна ідіосинкратична інтоксикація
- B. Алкогольне сп'яніння
- C. Алкогольний абстинентний делірій
- D. Психоз Верніке
- E. Психотичний розлад, спричинений алкоголем

143. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до лікаря-психіатра у супроводі матері. Під час бесіди поводить зухвало, швидко та багато говорить, сміється, намагається 'залицятися' до молодшого персоналу. Зі слів матері: донька витратила всі збереження на сумнівний бізнес, приводить додому незнайомих людей і ночами не спить, така поведінка спостерігається два тижні, хоча до цього вона весь час лежала у ліжку, не вживала їжі, не стежила за особистою гігієною, ні з ким не спілкувалася. Який найімовірніший діагноз?

- A. Біполярний афективний розлад
- B. Маніакальний епізод
- C. Емоційно нестабільний розлад особистості
- D. Шизоафективний розлад
- E. Дистимія

144. Пацієнт віком 28 років скаржиться на пригнічений настрій протягом останніх 5-ти тижнів. Почувався пригніченим, зі зниженням концентрації, енергії та інтересу до своїх звичайних захоплень. Із анамнезу відомо, що 6 тижнів тому до цього візиту був у відділенні невідкладної допомоги з приводу гострого нападу астми, де йому призначили преднізон. Який найімовірніший діагноз?

- A. Велика депресія
- B. Розлад адаптації
- C. Розлад настрою, спричинений психоактивними речовинами
- D. Дистимія
- E. Розлад настрою внаслідок загального захворювання

145. Під час огляду пацієнтки віком 25 років спостерігається: знерухомлена, вираз обличчя мінливий, відображає страх, здивування або захоплення, на запитання лікаря не реагує. Через кілька днів пацієнтка пішла на контакт та розповіла, що спостерігала, як 'янгולי спустилися на променях світла та вступили у боротьбу з демонами'. Не пам'ятає, коли і як вона опинилася в лікарні. Який психопатологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Псевдоремінісценція
- B. Конфабуляція
- C. Аменція
- D. Делірій
- E. Онейроїд

146. Пацієнтка віком 18 років має постійне відчуття порожнечі всередині, часто мінливий настрій. Емоційно холодна, відчуває труднощі у спілкуванні, має багато знайомих, але ні з ким не близька. У підлітковому віці була анорексія. Тричі за життя спостерігалася самопошкоджувальна поведінка. Який найімовірніший діагноз?

- A. Депресивний розлад
- B. Межовий розлад особистості
- C. Шизотиповий розлад
- D. Біполярний афективний розлад
- E. Нарцистична травма

147. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на постійну тривогу, пригнічення настрою через неконтрольований апетит, потяг до їжі зі 'швидкими вуглеводами', неможливість схуднути. Звинувачує себе в тому, що не може контролювати прийоми їжі, часто викликає в себе блювання, без потреби у значному дозуванні приймає проносні та діуретики, а також виснажує себе силовими вправами, не набираючи при цьому м'язову масу, що ще більше викликає почуття провини. Зазначає, що неконтрольовані прийоми їжі з'явилися після пережитого стресу. Об'єктивно спостерігається: гіперстенічна, набряки на обличчі, шкірні покриви бліді. Розрахунок індекса Кетле вказав на передожиріння. Під

час бесіди з лікарем фіксована на переживаннях з приводу зовнішності і ваги, емоційно лабільна, тривожна, астенична. Який імовірний розлад наявний у пацієнтки?

- A. Нервова анорексія
- B. **Нервова булімія**
- C. Компульсивне переїдання
- D. Генералізований тривожний розлад
- E. Обсесивно-компульсивний розлад

148. Пацієнтка віком 36 років протягом останніх 8-ми місяців відмовлялася виходити з дому, вважаючи, що сусіди намагаються їй нашкодити. Вона боїться, що якщо вони побачать її, то завдадуть болю, і знаходить багато дрібних доказів на підтримку цього, зокрема: сусіди залишали свої сміттєві баки на вулиці, щоб вона перечепилася, паркували свої машини біля своїх під'їздів, щоб могли сховатися за ними та шпигувати за нею, і проходили повз її будинок, щоб спробувати зазирнути, де вона ховається. Пацієнтка стверджує, що настрої у неї хороший і було б 'краще, якби вони залишили її в спокої'. Заперечує, що чула, як сусіди чи хтось інший з нею розмовляють, але впевнена, що вони планують 'спричинити їй смерть і каліцтво'. Який найімовірніший діагноз?

- A. Шизоафективний розлад
- B. Шизофренія
- C. Шизофренний розлад
- D. Велика депресія з психотичними ознаками
- E. **Маячний розлад**

149. Пацієнт віком 26 років скаржиться на порушення функції пам'яті - не може згадати, що робив ввечері напередодні або як придбав собі ту чи іншу річ. Зазначає, що друзі розповідають йому про спільно проведені вечори, а він не пам'ятає, що був там, хоч і бачить себе на фото. Інколи має відчуття, що він спостерігає за своїм життям з боку третьої особи. Із розповідей сестри відомо, що у віці 4-х років пацієнт кілька разів переживав сексуальне насильство, чого сам не пам'ятає. Дані ЕЕГ, МРТ патології не визначають. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Дисоціативний розлад ідентичності**
- B. Судинна деменція
- C. Розлад деперсоналізації/дереалізації
- D. Межовий розлад особистості
- E. Конверсійний розлад

150. Який із нижченаведених варіантів депресії не належить до тих, що можуть бути асоційовані з COVID-19?

- A. Короткотривала депресивна реакція
- B. **Постшизофренічна**
- C. Органічна
- D. Біполярна
- E. Рекурентна